

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย

จุดคัดกรอง

หน่วยตรวจรักษาทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อ

1. ใช้ในการประเมินผู้ป่วยค้นหาปัญหาและความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการตรวจรักษาผู้ป่วย
2. เพื่อแยกผู้ป่วยโรคติดต่อ ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะแพร่กระจายเชื้อ โรคอุบัติใหม่ อุตุนิยมวิทยา จากผู้ป่วยทั่วไป
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานจุดคัดกรองเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ

ขอบเขต

ผู้ป่วยนอกทุกรายที่มารับบริการ ณ จุดคัดกรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พยาบาล : ชักประวัติ ประเมินอาการคัดกรองเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วน กรณีที่ต้องส่งห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บันทึกข้อมูลลงในระบบ HIS -iMed ทุกครั้ง ยกเว้นส่งต่อผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง บันทึกข้อมูลลงใน visit slip

ผู้ช่วยพยาบาล : มีส่วนร่วมในการคัดกรอง ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาล รวมทั้งให้การพยาบาลเบื้องต้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

คำจำกัดความ

การคัดกรองผู้ป่วย หมายถึง การตรวจประเมินสภาพผู้ป่วย ณ จุดบริการ เพื่อให้ทราบถึงภาวะเจ็บป่วย เพื่อนำข้อมูลมาจำแนกประเภทและจัดลำดับการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยตามความรุนแรงหรือเร่งด่วน และให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมกับปัญหาการเจ็บป่วย

ขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วย (ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที)

1. ประเมินคัดแยกประเภทผู้ป่วย ตาม MOPH ED Triage คือ ประเภทฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) ประเภทฉุกเฉิน(สีชมพู) ประเภทปานกลาง(สีเหลือง) ประเภทเล็กน้อย(สีเขียว) และประเภทไม่เร่งด่วน(สีขา)
2. คัดแยกผู้ป่วยโรคติดต่อออกจากผู้ป่วยทั่วไป สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เช่น Mask พร้อมแยกผู้ป่วยไปยังจุดโซนแยกโรค พร้อมสื่อสารให้ทีมทราบใน visit slip
3. ชักประวัติ อาการและอาการแสดงผู้ป่วย
 - อาการความผิดปกติ ปัญหาความเจ็บป่วย ความต้องการที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
 - ความไม่สบายต่าง ๆ เช่น อาการปวด คลื่นไส้
 - กรณีชักประวัติพบว่าผู้ป่วยมารับการตรวจไม่ตรงกับหน่วยตรวจนั้น ๆ ให้คำแนะนำผู้ป่วยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้ถูกต้อง
4. ประเมินสัญญาณชีพร่วมกับอาการที่ได้จากข้อมูลการซักประวัติ
5. จัดส่งผู้ป่วยตามเกณฑ์ MOPH ED Triage การคัดแยกประเภท ดังนี้
 - ประเภทฉุกเฉินส่งห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินทันที
 - ประเภทปานกลาง ปานกลางและไม่เร่งด่วน ส่งหน่วยตรวจให้ถูกต้องตามอาการเจ็บป่วย

ลักษณะจำเพาะเจาะจงสำหรับส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกเฉพาะทางโดยไม่ต้องผ่าน OPD ทัวไป

Chief complain	รายละเอียด	หน่วยตรวจ
Arrhythmias ที่มีอาการร่วม เช่น ใจสั่น	HR> 100 ,< 40 /min, หัวใจเต้นผิดจังหวะ,ชีพจร จังหวะไม่สม่ำเสมอ	หัวใจและหลอดเลือด
หัวใจล้มเหลว	มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ(RR ≤ 30 bpm, SPO ₂ >95 %) นอนราบไม่ได้,มีภาวะบวม	หัวใจและหลอดเลือด
เต้านม	คลำก้อนได้ที่เต้านม, มีสารคัดหลั่ง หรือเจ็บเต้านม	ศัลยศาสตร์
ช่องท้อง	คลำก้อนได้ที่ท้อง ปะริกษาส่องกล้อง	ศัลยศาสตร์
ทวารหนัก	ริดสีดวง หนองที่ก้น Anal fissure, fistula in anal, ปะริกษาส่องกล้อง	ศัลยศาสตร์
อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด	เกิน 24 ชั่วโมง	ศัลยศาสตร์
แขนขาขาดเลือด/เส้นเลือด	เส้นเลือดอุดตัน ปวดเวลาใช้แขน มือเท้าเย็น แผลเรื้อรัง/ซิดดำ	ศัลยศาสตร์
ทำเส้นฟอกไตเตรียมฟอกไตหน้าท้อง		ศัลยศาสตร์
อุบัติเหตุศีรษะกระแทกไม่โดนส่วนอื่น	เกิน 24 ชั่วโมง	ศัลยศาสตร์
Chronic wound	แผลเท้าเบาหวาน แผลกดทับ venous ulcer Ischemic ulcer Neuropathic ulcer แผลจากการฉายแสง	ศัลยศาสตร์
แผลเป็นที่มีปัญหา	แผลเป็นนูน คีลอยด์ แผลเป็นหดรั้ง แผลเป็นแตก เป็นแผลเรื้อรัง เจ็บหรือคันเรื้อรัง แผลเป็นที่ผู้ป่วย กังวลเรื่องความสวยงาม	ศัลยศาสตร์
ความผิดปกติทางใบหน้าหรือนิ้ว	ปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหูผิดปกติ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หนังตาตก หนังตาเกิน ใบหน้าผิดปกติที่ต้องการแก้ไข นิ้วเกิน	ศัลยศาสตร์
แผลบาดเจ็บ ต้องการเสริมความงาม		ศัลยศาสตร์
ประวัติอุบัติเหตุทางตา	ร่วมตามัวลงอย่างมาก หรือตาแดงที่เห็นได้ชัดเจน	ตา
อุบัติเหตุทางตา	มีเลือดออกไม่หยุด/เกิดจากสารพิษ/สารเคมี	ตา
ตามัว ตาพร่าฉับพลัน		ตา
ตาแดงมาก		ตา
ปวดตามาก		ตา
ก้อนบวมแดงที่ตา		ตา

Chief complain	รายละเอียด	หน่วยตรวจ
จมูกและคอ	ภูมิแพ้ เจ็บคอเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน ไซนัสอักเสบ คัดจมูก ปวดสันจมูก เลือดกำเดาไหล ก้อนที่คอ และก้อนในปาก เสียงแหบ	หู คอ จมูก
อาการทางหู	หูอื้อ การได้ยินลดลง ปวดหู น้ำไหลจากหู เสียงดังในหู เช่น วี้ง เสียงแมลง	หู คอ จมูก
หูแว่วเสียงคน จับใจความได้		จิตเวช
ซึมเศร้า ภาพหลอน ระวัง	เริ่มเป็นครั้งแรกก่อนอายุ 60 ปี ถ้า > 60 ปี ส่งอายุรศาสตร์	จิตเวช
เครียดมาก มีความคิดอยากตาย ทำร้ายตนเอง	หากทำร้ายตนเอง เป็นเวลาเกิน 48 ชม.	จิตเวช
กระดูกหัก ยกเว้นซี่โครงและศีรษะ		กระดูกและข้อ
ปวดหลัง	ปวดหลังร้าวลงขา	กระดูกและข้อ
ตั้งครรภ์		สูตินรี
โรคทางสูตินรีเวชวิทยา		สูตินรี
มีใบรายงานชันสูตรบาดแผลจากตำรวจ	ได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่อื่นแล้ว (ส่วนมากเป็น traffic injury + assault	นิติเวช at ER
Sexual abuse		นิติเวช at ER
ผู้ต้องสงสัยมีใบนำส่งตรวจร่างกายจากตำรวจ		นิติเวช at ER
ผู้ป่วยกรณีอื่น อายุน้อยกว่า 15 ปี		เด็กป่วย

MFU Medical Center Hospital Patient Triage

ผู้ป่วยมีภาวะอวัยวะสำคัญทำงานล้มเหลว (Life-threatening organ failure)

ผู้ใหญ่ (อายุ > 15 ปี)

» ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- หัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest)
- หัวใจเต้น > 150 /min
- หัวใจเต้น < 50 /min ร่วมกับมี

อาการเจ็บแน่นหน้าอก มีภาวะช็อค

» มีภาวะช็อค (shock)

- SBP < 90 หรือ MAP < 60 mmHg)

- ผิวหนังซีด ตัวเย็น เหงื่อแตก

» ระบบการหายใจ

- หายใจลำบาก (respiratory distress)
- หายใจ > 30 ครั้ง หรือ < 8 ครั้งต่อนาที
- ภาวะหยุดหายใจ (apnea)
- วัด O₂ sat < 90 % ที่มีอาการเหนื่อย ร่วมกับ

หายใจมี Retraction(O₂sat < 90 %

ยกเว้น ผู้ป่วย COPD keep 88 - 92 %)

- ผู้ป่วยมีภาวะทางเดินหายใจอุดตัน (Airway obstruction)

» ระบบประสาทและสมอง

- ชีมลงปลุกไม่ตื่น , ชักเกร็งเรียกไม่รู้สึกตัว (seizure)

เด็ก (อายุ 0 เดือน – 15 ปี)

- เจียว ไม่ตอบสนอง ตัวอ่อนปวกเปียก
- หายใจเฮือก หายใจเหนื่อย
- O₂ Sat < 90 % (ยกเว้นผู้ป่วย heart)
- ชักเกร็งไม่รู้สึกตัว
- ชีม ปลุกไม่ตื่น
- อายุ < 1 ปี HR >220 /min,
≥ 1 ปี HR > 180/min

สูติ-นรีเวช

- ✓ Uterine contraction ทุก 2 นาที severe pain (PS ≥7)
 - ✓ เจ็บครรภ์อย่างเบ่ง หรือทารกกำลังคลอดโผล่ส่วนนำใด ๆ ของเด็กออกมาให้เห็น
- และ ปฏิบัติตาม CPRs สติ

ใช้
→

Triage Level 1
ส่งห้องฉุกเฉิน
ทันที
(Immediate)

****กรณีผู้ป่วย on home O₂ วัด O₂sat < 90 % และไม่มีหายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจไม่มี Retraction พิจารณา on O₂ support ก่อน ****

ไม่ใช่

สัญญาณชีพอยู่ในภาวะอันตราย

- SBP > 180 mmHg หรือ DBP > 110 mmHg (ปฏิบัติตาม CPG Hypertensive crisis)
- HR > 120/min (ในขณะพัก)
- RR 21 –30/min ร่วมกับ หายใจมี Retraction หรือได้ยินเสียงหายใจผิดปกติโดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง เช่น wheeze, stridor เป็นต้น
- O₂ sat 90 –94 ที่มีอาการหายใจเหนื่อย ร่วมกับ หายใจมี Retraction

» แผนกอายุรกรรม

- Stroke FASTTRACK: เวียนศีรษะร่วมกับทรงตัวไม่ได้ ตามองไม่เห็นเฉียบพลันปากเบี้ยว พุดไม่ชัด อ่อนแรงครึ่งซีก ≤ 4 ชั่วโมงครึ่ง (BEFAST) หรือมีอาการภายใน 72 ชั่วโมง
 - MI FASTTRACK: เจ็บแน่นกลางอก เจ็บร้าวไปที่คอ กราม ไหล่
 - Sepsis FASTTRACK : NEWS ≥ 5
 - สงสัยอาการแพ้รุนแรง (ผื่นคัน ปากบวม ร่วมกับ หายใจเหนื่อย แน่นหน้าอก ถ่ายเหลว หรืออาเจียน)
 - ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดแล้วมีไข้ (Temp > 38 °C)
 - ได้รับยาเกินขนาด หรือประวัติได้รับหรือสัมผัสสารพิษ
 - วูบ/หน้ามืดภายใน 24 ชั่วโมง
 - ชี้น/สับสน ภายใน 72 ชั่วโมง
- ### » นิติเวช
- ถูกทำร้ายร่างกาย ภายใน 24 ชม. หรือถูกกระทำซ้ำภายใน 72 ชม.

» แผนกศัลยกรรม

- อาเจียนเป็นเลือด หรือ ถ่ายเป็นเลือดสด หรือ ถ่ายดำ ภายใน 1 สัปดาห์
- Pain score ≥ 7 ที่สงสัยอวัยวะที่สำคัญ ได้แก่ ศีรษะ และคอ หรือ หน้าอก หรือ ช่องท้อง
- อุบัติเหตุรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ / ตกจากที่สูงมากกว่า 5 เมตร /คนเดินถนนถูกรถชน
- ถูกแทงที่คอ / หน้าอก / ช่องท้อง/อุบัติเหตุที่มีเลือดออกมาก (active bleeding)

» แผนกกระดูก

- อุบัติเหตุกระดูกหักหรือข้อหลุดมาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

» แผนกสูติ-นรีเวช

- สงสัยท้องนอกมดลูก: ประจำเดือนขาด หรือมีประวัติตั้งครรภ์ **ร่วมกับ** ปวดท้องน้อยมาก (PS ≥7) และเลือดออกทางช่องคลอดเฉียบพลัน
- เลือดออกมากทางช่องคลอด (เช่น เปียกชุ่มผ้าอนามัย 1 ผืน เปลี่ยนทุก 1 ชม.) (active bleeding)

» แผนกตา

- สารเคมี / พิษจากสัตว์กระเด็นเข้าตา
- อุบัติเหตุทางตาที่เลือดออกมาก (active bleeding), ผู้ป่วย Rupture eye glove

» แผนกหู คอ จมูก

- ผู้ป่วย epistaxis uncontrolled bleeding
- สิ่งแปลกปลอมติดในหู จมูก และคอ ภายใน 24 ชั่วโมง

» แผนกจิตเวช

- เสี่ยงต่อการทำร้ายร่างกายตนเองหรือผู้อื่น หรือมีภาวะคลุ้มคลั่ง ***ตามแนวปฏิบัติ Code ม่วง***

Triage Level 2

ส่งห้องฉุกเฉิน
ภายใน 15
นาที
(Urgency)

ใช่

ส่งแผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช่

เด็ก (อายุ 0 เดือน – 15 ปี)

สัญญาณชีพอันตรายสำหรับเด็ก

อายุ	HR	RR	Systolic BP
< 1 mo	> 190	> 60	< 60 mmHg
1 mo – 12 mo	> 180	> 55	< 70 mmHg
1 yr – 3 yr	> 140	> 40	70 + (อายุ × 2)
3 yr – 5 yr	> 120	> 35	70 + (อายุ × 2)
6 yr – 10 yr	> 120	> 30	70 + (อายุ × 2)
> 10 yr	> 100	> 20	< 90 mmHg

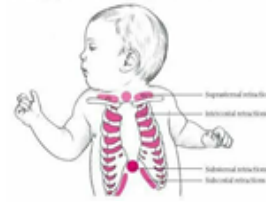
ที่มา : ENA 2023 : ESI (5th), PALS 2020

✓ หายใจเร็ว ร่วมกับ Retraction ปีกจมูกบาน

✓ O₂ Sat < 94 %

✓ Alteration of consciousness

✓ ปวดมาก NIPS, FLACC, FACES, NRS > 7



* ไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ร่วมกับอย่างใดอย่างหนึ่ง

• ไอมีเสมหะปนเลือด

• มีไข้ตอนเย็น

• หายใจเหนื่อย เจ็บหน้าอก

• อ่อนเพลีย น้ำหนักลด

* ผื่นแดง หรือ ตุ่มน้ำตามร่างกาย

*** ผื่นแดงตามฝ่ามือฝ่าเท้า รอบปาก ตามร่างกาย

ส่งห้องแยกโรคทันที

** อุบัติเหตุ ไฟดูด น้ำร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย ภายใน 24 ชม. พิจารณาส่ง ER **

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน(Stroke Fast Track)

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส่วนที่ 1 จุดคัดกรอง

มาเอง/ญาตินำส่ง/
EMS นำส่ง



ผู้ป่วยมาตรวจที่ ER/OPD
เวลาน.



มีอาการตาม BEFAST (1 ใน 5 อาการ+Time ≤ 6 ชั่วโมง)

- ☐ B Balance : เสียการทรงตัว เดินเซ วิงเวียน หรือ ปวดศีรษะรุนแรง
- ☐ E Eye : มองไม่เห็น มีอาการตามีตบอดด้านเดียว หรือ 2 ข้างทันที มองเห็นภาพซ้อน
- ☐ F Face : ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยวฉับพลัน
- ☐ A Arm : แขน ขาอ่อนแรง หรือชาครึ่งซีก
- ☐ S Speech : พูดไม่ชัด เสียงเปลี่ยน ลิ้นแข็ง พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่ออกทันทีทันใด
- ☐ T Time : ระยะเวลาตั้งแต่ที่เห็นผู้ป่วยปกติครั้งสุดท้าย จนมาถึงโรงพยาบาล ≤ 6 ชั่วโมง

เวลาที่พบผู้ป่วยปกติ (Last seen normal)น., เวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล.....น.



เวลาทั้งหมด (Onset) คือชั่วโมงนาที



เข้าระบบ Fast Track

แบบคัดกรองผู้ป่วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก

(Chest Pain Checklist)

เริ่มเจ็บหน้าอก วันที่.....เวลา.....น. วันที่มาโรงพยาบาล.....

ผู้ป่วยยื่นบัตรซักประวัติที่หน่วยตรวจแรก(FMC).....เวลา.....น.

CC :Pain scare =

Name.....

HN.....AN.....

Age.....Ward.....

Date.....

การซักประวัติอาการเจ็บแน่นหน้าอกภายใน 12 ชั่วโมง

☐ เจ็บแน่นกลางอกคล้ายมีอะไรมาทับเป็นมากเมื่อออกแรง หรือจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่
☐ เจ็บร้าวไปที่คอ กราม ไหล่ แขน
☐ อาการเจ็บต่อเนื่องนาน 20 นาที
☐ อาการร่วมอื่น ๆ เช่น เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะเป็นลม หอบหืด
☐ อาการดีขึ้นเมื่ออมยาใต้ลิ้นหรือหยุดพัก

การซักประวัติความเสี่ยง

☐ เพศชาย อายุ > 35 ปี	☐ DLP
☐ เพศหญิง อายุ > 35 ปี	☐ Smoking
☐ HT	☐ Drugs abuse
☐ DM	☐ มีประวัติครอบครัวเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ
	☐ มีประวัติเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ

- หากมีอาการ 1 ข้อ และความเสี่ยง 1 ข้อ ทำ EKG ทันที
- หากมีอาการ 2 ข้อ ส่งผู้ป่วยไปยัง ER ทันที

แบบบันทึกเวลาสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

เวลา	รายการ	หน่วยที่บันทึก
	ทำ EKG 12 Lead	ER / OPD / WARD
	รายงานแพทย์ประจำเวร (แพทย์มาถึง/ตรวจผู้ป่วยเวลา.....น.	ER / OPD / WARD
	1 st EKG STEMI DIAGNOSIS (EKG แผ่นแรกที่แปลผล STEMI	ER / OPD / WARD

ข้อบ่งชี้ในการปรึกษาแพทย์ออร์โธปิดิกส์

1. การบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury)
2. การติดเชื้อบริเวณโดยรอบข้อเทียม (periprosthetic joint infection)
3. กระดูกหักหรือข้อเคลื่อนหลุด (fractures/ dislocation)
4. การบาดเจ็บของเส้นเอ็น (tendon injury)
5. การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (sport injury: cruciate ligament, rotator cuff, meniscus, etc)
6. แผลเปิดเข้าข้อ(open joint injury)

แนวทางการบริหารจัดการและนัดตรวจผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

1. ภาวะทางสูติศาสตร์ ได้แก่ การตั้งครรภ์ทุกราย
2. ภาวะ/โรคทางนรีเวชวิทยา ได้แก่
 - 2.1 การติดเชื้อของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ PID
 - 2.2 ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ช่องคลอด และปากมดลูกเช่น genital vaginal หรือ cervix lesions
 - 2.3 ก้อนเนื้องอกของมดลูกและรังไข่
 - 2.4 ภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 - 2.5 ภาวะ PCOS
 - 2.6 ภาวะเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
 - 2.7 ผู้ป่วยต้องการตรวจโดยเฉพาะกับแพทย์เฉพาะทาง
 - 2.8 การให้คำปรึกษาและวางแผนการมีบุตร
 - 2.9 การให้คำปรึกษาและคุมกำเนิด

กรณี Urgent/Emergency หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยหรือสงสัยภาวะ/โรค ดังต่อไปนี้

1. Ectopic pregnancy
2. Ovarian cyst with complication
3. Acute PID with SIRS or severe pain
4. Abnormal vaginal bleeding with shock
5. Active labor

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาด้านสูติกรรม ในเวลาราชการ

หากมีอาการต่อไปนี้ ให้ตรวจรักษาและดูแลที่ ER = ได้รับการประเมินว่า ESI 1

- Cardiac arrest โดยมีอาการไม่รู้สึกตัว หรือไม่หายใจ หรือไม่มีชีพจร
- Severe respiratory distress ได้แก่ ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้, พูดเป็นประโยคสั้นๆ, หายใจเร็ว แรงลึกและใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ
- ชีต และผิวหนังเหี่ยวออกท่วมตัว
- เลือดออกปริมาณมาก ร่วมกับ สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง
- ทารกกำลังคลอดโดยมีส่วนนำใด ๆ ของทารกโผล่ออกมาให้เห็น
- กำลังชัก

ใช้

Triage Level 1
ส่งห้องฉุกเฉินทันที
(Immediate)

GA ≥ 24 wks

- สงสัยเจ็บครรภ์ ท้องแข็ง
- สงสัยมีน้ำเดิน
- สงสัยมีมูกเลือด/เลือดออกช่องคลอด
- สงสัยทารกในครรภ์ดิ้นลดลง
- วัดความดันโลหิต $\geq 140/90$ mmHg หรือสงสัยครรภ์เป็นพิษ
- มีอาการแพ้ท้องรุนแรง จนกินไม่ได้
- มีอาการปวดท้อง มีไข้ และสารคัดหลั่งมีกลิ่นเหม็นทางช่องคลอด

GA < 24 wks

พยาบาล โทรประสานส่ง
ต่อ ห้องคลอด

OPD สูติรีเวช
ศาสตร์

แนวทางการรับผู้ป่วยหน่วยตรวจหู คอ จมูก

อายุ < 15 ปี

- ต้องการทำการทดสอบ skin Prick test
- การได้ยินลดลง
- ตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กอายุ > 2 เดือน

อายุ > 15 ปี

กลุ่มอาการทางหู

- ปวดหู pain score > 7 คะแนนรวมกับมีหน้าเบี้ยว
- บ้านหมุน สัมพันธ์กับท่าทาง
- การได้ยินลดลง/เสียงดังในหู
- เวียนศีรษะ บ้านหมุน ที่มีใบส่งตัวระบุแพทย์ ENT

กลุ่มอาการช่องปากและคอ

- มีก้อนโตเร็ว ผิวไม่เรียบ สงสัย CA
- คอบวมโต กลืนลำบาก หายใจลำบาก
- เสียงแหบมานาน > 2 สัปดาห์
- นอนกรน
- แผลในช่องปากเรื้อรัง ไม่หาย

กลุ่มอาการทางจมูก

- อาการทางจมูก ภูมิแพ้หรือไซนัสอักเสบ มีประวัติการรักษาจาก GP หรือรพ.อื่นมาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
- จมูกไม่ได้กลิ่น
- Trauma in ENT > 24 ชั่วโมง
- FB in ENT > 24 ชั่วโมง
- Abscess ไข้ บวม แดง บริเวณหู คอ จมูก
- มีใบส่งตัวพบแพทย์ ENT จากรพ.อื่น
- ขอหนังสือส่งตัว

แนวทางการรับผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์

Urgency condition > พยาบาลโทรปรึกษาแพทย์ประจำหน่วยตรวจโดยตรงเพื่อรักษาทันที

- **Cardio** : recurrent chest pain despite medication <acute heart failure
- **Chest** : hemoptysis, acute pulmonary embolism
- **GI** : acute liver failure (abnormal liver enzyme+ coagulopathy +encephalopathy), moderate hepatitis (AST,ALT > 5xUNL) acute pancreatitis(serum amylase >3-5x UNL)
- **Nepho** : AKI stage2 (Cr2-3x baseline in 7 day or Oliguria) uremic encephalopathy, Na<120 or >150 K >6 or<3
- **Hemato** : Hb <7 g/dl, plt < 50,000, WBC > 50,000 or <1,000, suspected acute leukemia, INR > 5.0, deep vein thrombosis, febrile neutropenia
- **Endocrine** : DKA/HHS, FBS>300mg/dl, thyroid storm
- **ID** : 1ST diagnosed HIV infection
- **Skin** : suspected SJS/DRESS
- **Onco** : SVC syndrome, fever after CMT
- **Neuro** : neurological deficit within 2 weeks > AOC , weakness, stiff neck positive

Semi - Urgency condition > พยาบาลประสานส่งต่อข้อมูลระหว่างแผนก เพื่อนัดหมายตามความเหมาะสม

- **Cardio** : HF(NYHA FC > 3 or NT-ProBNP > 1000) NSTMI whit grace > 140
- **Chest** : Lung mass, new pleural effusion
- **GI** : liver mass, hepatitis(AST,ALT > 3-5xUNL) chronic diarrhea, new onset ascites, decompensated, cirrhosis
- **Nepho** : AKI, suspected glomerular disease(Nephritis/Nephrotic/RPGN)
- **Hemato** : suspected hematologic malignancy, pancytopenia, bicytopenia, WBC < 2,000, PLT < 80,000
- **Endocrine** : adrenal insufficiency, crushing, TG > 1,000
- **ID** : TB infection, prolong fever
- **Skin** : psoriasis with BSA>30%, exfoliative dermatitis, immune bullous disease, suspected skin cancer

เอกสารอ้างอิง

- กรมการแพทย์. (2561). *MOPH ED. TRIAGE*. สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. (2556). *คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับบริหาร ณ ห้องฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด*. นนทบุรี : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล. (2565). *มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5* (พิมพ์ครั้งที่ 2). ก.การพิมพ์เทียนทอง.